Diskussion 814

Datum: 1938-03-19
Kammare: Första kammaren
Antal yttranden: 10
Källa: Tal om Kvinnor: Annotated Corpus, byggd på The Swedish Parliament Corpus (Yrjänäinen m.fl. 2024).
Projekt: https://github.com/DigitalHistory-Lund/ToK-Preparer
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18211787
Version: 2026.10.13

Markerade ord: ¹ kvinna-ord, ² släktskaps- och tilltalsord, ³ yrkestitlar.

1. Martin Svensson (–, man)

Herr talman! Den föregående ärade talaren preciserade vad reservationen innebär och i vilkan mån den avviker från vad statsutskottet har föreslagit. Han påyrkade, att Kungl. Maj:t skulle få en fullmakt att lämna garantibidrag till speciella alkoholistanstalter, och han ansåg, att detta skulle vara till god hjälp för en ny anstalt, som Godtemplarorden ämnar inrätta.

Det förhåller sig nu så, att en **kvinnlig¹** alkoholistanstalt har ett sådant ga-

Nu begära reservanterna, att Kungl. Maj:t skall få en fullmakt, som Kungl. Maj:t inte har begärt och som Kungl. Maj:t i departementschefens yttrande har uttalat sig emot. Jag kan inte finna, att det under dessa omständigheter är lämpligt, att riksdagen lämnar en sådan fullmakt. Dessutom kan det medföra en ökning av det beräknade anslaget. Detta är visserligen ett förslagsanslag, raen man bör ju vid fastställandet av anslag inte med öppna ögon lämna rum för överskridanden.

Jag ber, herr talman, att på dessa skäl få yrka bifall till statsutskottets hemställan.

2. Martin Svensson (–, man)

Herr talman! Vid denna punkt har jag jämte några andra utskottsledamöter avgivit en reservation, och jag ber att få ange några av skälen för densamma.

1936 års riksdag beslöt att begränsa arbetstiden för personalen vid sinnessjukhusen till 218 timmar per 30 dagar. Detta beslut fattades enhälligt. Det har inte varit i kraft längre än ett år, förrän Kungl. Maj:t nu föreslår, att riksdagen skall ändra på detta beslut och gå in för 48 timmars arbetsvecka vid sinnessjukhusen. Medicinalstyrelsen har fått i uppdrag att verkställa en utredning om konsekvenserna för statens vidkommande av en sådan förändring, och styrelsen har beräknat utgiftsökningen till 380,000 kronor för ett halvt

Anslag till statens sinnessjukhus. (Forts.) budgetår. Därvid har inte tagits med i beräkningen de eventuella kostnaderna för anordnandet av bostäder. Men vi få heller inte bortse ifrån, att det inte stannar endast vid ökade kostnader för staten, utan att en sådan förkortning av

arbetstiden också ovillkorligen för med sig ökade kostnader för landstingen. Då frågan vid tidigare tillfällen behandlades, tog man också hänsyn till detta förhållande. För ett par år sedan beräknades, att utgiftsökningen för landstingens del skulle belöpa sig till omkring 8 miljoner kronor. Det har visat sig, att de landsting, som gått ned till 48 timmars arbetsvecka, fått kostnaderna ökade utöver vad som beräknades i den kalkylen. Om man beräknar de ekonomiska konsekvenser, som den föreslagna arbetstidsbegränsningen för närvarande skulle medföra för landstingens del, skulle utgiftsökningen komma att visa sig vara mindre än den var för ett par år sedan, därför att landstingen nu 1 stor utsträckning förkortat arbetstiden vid kroppssjukhusen. De ha därvidlag att följa de direktiv, som lämnats av medicinalstyrelsen, vilken tillrått landstingen att begränsa arbetstiden till 216 timmar per 28 dagar. Landstingen torde allmänt ha efterföljt dessa direktiv, varför detta är maximiarbetstiden vid landstingens sjukvårdsinrättningar. Men man får sannolikt räkna med att ett genomförande av den förkortning av arbetstiden vid sinnessjukhusen, som här föreslås, drar med sig samma krav ifrån personalen vid kroppssjukhusen. Man kan därför sannolikt beräkna kostnadsökningen till 4 miljoner kronor, lågt räknat.

Man bör också tänka på att de ökade utgifter, som den föreslagna arbetstidsbegränsningen kommer att medföra för landstingen, i sinom tid även måste drabba staten. Det föreligger i år motioner om skatteutjämning för landsting, som äro synnerligen skattetyngda, och i den mån staten genom sina beslut framkallar ökade utgifter för landstingen, stärkas ytterligare skälen för att staten bör åtaga sig att mildra skattetrycket för landstingen.

Jag kan inte se, att vi här ha att göra med en personal, som är överansträngd. Man skulle mycket väl kunna vänta och se tiden an och låta landstingen mera 1 ro sköta de förhandlingar, som de för närvarande föra med sin ifrågavarande personal.

Jag tvivlar inte på att staten skall lyckas effektuera ett beslut i enlighet med utskottets hemställan och anskaffa den nya personal, som därigenom blir erforderlig — 119 manliga och 172 **kvinnliga**[1] sjukvårdsfunktionärer och 26 ekonomister — ty redan nu äro förmånerna vid sinnessjukhusen så stora, att personal drages över från kroppssjukhusen till sinnessjukhusen. Kvalifikationerna för anställning vid sinnessjukhus äro också mindre än vid kroppssjukhusen. Däremot komma svårigheterna att anskaffa den nödiga personalen vid kroppssjukhusen att växa. Vi veta, att det för närvarande råder stor brist på **sjuksköterskor**[3], och detta förhållande utgör också ett skäl för uppskov med denna fråga, så att man hinner rekrytera sköterskekåren i tillräcklig omfattning.

Departementschefen har för kommande budgetår beräknat kostnaderna för genomförandet av denna arbetstidsreglering till 260,000 kronor för ett halvt år. Denna beräkning innebär, såsom jag 1 början av mitt anförande antydde, en nedprutning av medicinalstyrelsens fy räkning. Utskottet anger nu ett ännu lägre belopp, 200,000 kronor, och tänker sig, att detta skulle vara tillräckligt, om man inte läte beslutet träda 1 kraft den 1 januari 1939 utan vid en något senare tidpunkt . Alla dessa beräkningar gälla dock endast för det kommande

budgetåret, och för de följande åren komma kostnaderna att uppgå till fulla beloppet, och säkerligen kommer medicinalstyrelsens beräkning inte att visa sig vara tilltagen i överkant.

Med stöd av vad jag anfört både i fråga om de ekonomiska konsekvenserna

Anslag till statens sinnessjukhus. (Forts.) såväl för stat som landsting och i fråga om svårigheten för landstingen att anskaffa den behövliga personalen, ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den av herr J. B. Johansson m. fl. avgivna reservationen.

3. Magnus Bäckström (–, man)

Herr talman! Då jag vid behandlingn av denna punkt ej kunnat följa utskottet utan antecknat en reservation, ber jag att få yttra några ord. Såsom den föregående talaren anförde, beslöt riksdagen 1936, att tjänstgöringstiden för sjukvårdspersonalen vid sinnessjukhusen från och med den 1 januari 1937 skulle utgöra 218 timmar per 30-dagarsperiod i stället för dåvarande 240 timmar per 30-dagarsperiod.

Departementschefen har under år 1937 anmodat medicinalstyrelsen att verkställa en utredning om kostnaderna, därest arbetstiden för sjukvårdsoch ekonomipersonalen vid statens sinnessjukhus begränsades till 48 timmar per vecka. Medicinalstyrelsen har verkställt denna utredning och kommit till det resultatet, att ett genomförande av den föreslagna arbetstidsbegränsningen skulle, enligt medicinalstyrelsens beräkningar, kräva nyanställande av 119 manliga och 172 **kvinnliga**[1] sjukvårdsfunktionärer, 26 ekonomister samt viss extra personal. Kostnaderna härför uppskattas av medicinalstyrelsen till omkring 380,000 kronor för tiden 1 januari—30 juni 1939, således ett halvt budgetår. Den nuvarande tjänstgöringstiden för sjukhuspersonalen, säger medicinalstyrelsen, utgör i genomsnitt 7.2 timmar per arbetsdag, under det genomsnittet med föreslagna 48 timmar per arbetsvecka blir 6.8 timmar per arbetsdag.

Nu säger utskottet i sin motivering: »Utskottet förutsätter emellertid, att 1 samband med arbetstidsregleringens genomförande alla förefintliga möjligheter till en rationell planläggning av personalens tjänstgöringstid och till effektivisering av arbetet prövas och tillvaratagas i syfte att undvika en alltför stor utökning av personalen. Om så sker, torde en icke oväsentlig begränsning av den i statsverkspropositionen beräknade personalkostnaden kunna åvägabringas.» Detta är mycket vackert sagt av statsutskottet, men det återstår att se, huruvida det kan förverkligas.

Enligt av medicinalstyrelsen lämnade uppgifter har personalen enligt nuvarande arbetstidstjänstgöring eller arbetsschema en tjänstgöring av 7.2 timmar per arbetsvecka med sådan fördelning, att var fjärde vardag är ledig och varannan helgdag, varjämte någon enstaka ledighetsdag inskjutes däremellan. Om man jämför denna arbetstidsförkortning från nuvarande 218 timmar per 30-dagarsperiod till 48-timmarsvecka, respektive 7.2 timmar per arbetsdag och 6.8 timmar per arbetsdag, så är det tydligen ej denna tidsskillnad mellan 7.2 och 6.8 timmar, som är det väsentliga, utan här gäller det fastmera, skulle jag tro, en

principfråga, att nå fram till 8-timmarsdagen.

Enligt en uppgift, som lämnades på avdelningen från medicinalstyrelsen, då frågan behandlades, har det i Norge, närmare angivet vid det stora sinnessjukhuset i Oslo, genomförts 48 timmars arbetsvecka. Men där utgjorde dagsledigheten endast en veckodag och var tredje söndag. Det visade sig således, att personalen vid våra sinnessjukhus har det bättre efter nuvarande arbetsschema, då det gäller ledighetsdagar, än vad fallet är i Norge, där 48-timmarsveckan är genomförd.

Nu är det väl någonting liknande utskottet avser att man skulle söka komma fram till, nämligen en rationalisering, där man inte skulle behöva öka personalen, utan där man skulle genomföra en annan tidsbegränsning och fördelning för att inte öka kostnaderna alltför mycket. Men riksdagen sade 1936, att den förutsatte, att det nuvarande arbetssehemat vid sinnessjukhusen fortfarande skulle vara gällande. Det torde sålunda vara svårt att förverkliga den fromma önskan, som statsutskottet här uttalar.

Herr talman! Jag anser, att när riksdagen så sent som 1936 tog ställning till det nu föreliggande spörsmålet, denna fråga för en tid framåt skulle vara avförd från dagordningen, men så synes ej vara fallet. För kroppssjukhusen, som drivas av landsting och kommuner, har medicinalstyrelsen den 30 maj 1936 utfärdat vissa anvisningar rörande den på sjukhusen anställda personalens arbetstid, anvisningar, som i viss mån ansluta sig till de grunder, vilka av 1936 års riksdag godtagits beträffande arbetstiden vid sinnessjukhusen. Tillämpningen av dessa anvisningar har flerstädes nyligen tagit sin början. Jag skulle tro, att de flesta landsting ha efterkommit medicinalstyrelsens anvisningar och verkställt en arbetstidsreglering, och därvid har den grund, som skapades här 1936, då det gällde sinnessjukhusen, varit normgivande.

Om utskottets förslag vinner riksdagens bifall, är det alldeles uppenbart, att detta kommer att återverka på av landsting och kommuner anställd sjukvårdsoch ekonomipersonal med förkortad arbetstidstjänstgöring, vilket kräver ytterligare ökning av personalen och därmed kommer att öka kostnaden väsentligt för landstingen. Jag vill beträffande de norrländska landstingen säga, att man där har försökt följa utvecklingen inom sjukhusvården genom utbyggnader och tillbyggnader av våra lasarett och ansträngt landstingen till den grad, att man naturligtvis vill gå försiktigt fram och pröva varje utgiftsökning, som man nu givetvis får vara beredd på att denna fråga kommer att påverka landstingens utgifter för framtiden; vi ha i de norrländska länen en landstingsskatt, som pendlar mellan 3:50 och 4:80. Å andra sidan vill man naturligtvis se till, att personalen har en dräglig tjänstgöring. Men man får inte se bort ifrån, att om riksdagen nu bifaller statsutskottets förslag, få vi kanhända omedelbart börja nya förhandlingar, och landstingen få fatta beslut beträffande arbetstidsregleringen ännu en gång. Jag anser, att man hade bort dröja med detta några år åtminstone.

Med de synpunkter, som jag nu framfört, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den

reservation, som av mig är fogad till punkt 75 av utskottets förevarande utlåtande.

4. Torsten Ström (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! De båda talare, som yttrat sig i denna punkt, äro var för sig reservanter. Båda tyckas hysa en stor oro för att denna fråga kommit upp ånyo efter att ha varit behandlad i riksdagen så sent som 1936. Det har dock inträffat en del saker, sedan denna fråga då var uppe till behandling. Sålunda ha vi fått arbetstiden reglerad för vissa yrkesgrupper, bland andra lantarbetarna. Med kännedom om de förhållanden, under vilka den personal arbetar, som det här rör sig om, är det förklarligt, att frågan nu återigen kommer upp till behandling för att få sin slutliga lösning.

Herr Svensson i Kompersmåla är vidare mycket rädd för att, i händelse riksdagen nu skulle bifalla Kungl. Maj:ts proposition, man snart nog skulle få kroppssjukhuspersonalen att kräva samma arbetstid. Inom landstingen, där vi syssla med dessa problem, är det för närvarande en tendens att reducera arbetstiden nedåt ganska avsevärt. Vi äro i de flesta lanstingen framme vid en arbetsvecka på 54 timmar, och det torde inte dröja så länge, innan man helt och hållet kommit fram till den arbetstid, som gäller för andra yrkesgrupper, även för kroppssjukhuspersonalen.

När vi ha behandlat denna punkt på tredje avdelningen inom statsutskottet, har man försökt komma fram till ett enhetligt resultat genom vissa eftergifter. Det har inte lyckats, utan det blev ändock reservationer på punkten. Vi ha emellertid tydligt skrivit, att, som herr Bäckström citerade, det torde finnas möjligheter till en rationalisering av driften och att det inte alls är uteslutet, att man kan nöja sig med ett avsevärt mindre antal personer än de av

Anslag till statens sinnessjukhus. (Forts.) medicinalstyrelsen beräknade. Departementschefen har angivit, att man kunde nedbringa kostnaderna från de 380,000, som medicinalstyrelsen har upptagit, till 260,000 kronor. Statsutskottet har sänkt denna summa ytterligare, eller ned till 200,000 kronor. Vi ha gjort detta med tanke på, att denna nya arbetstid avsetts träda i kraft den 1 januari 1939, under det vi däremot äro klart medvetna om, att det inte går att helt och fullt genomföra denna begränsning av arbetstiden då, utan att det kanske dröjer ett bra stycke in på år 1939. Följaktligen behöver inte tagas i anspråk den summa, som är av departementschefen föreslagen, utan man kan troligen nöja sig med ett avsevärt mindre belopp.

Herr talman! Sedan jag framhållit dessa synpunkter, ber jag att få yrka bifall till statsutskottets hemställan i denna punkt.

»Enligt vad utskottet inhämtat, lära redan med gällande bestämmelser vissa möjligheter föreligga att tillgodose det av motionären avsedda syftet. Såsom förutsättning härför gäller dock, att den kommunalt anställda **sköterskan³** äger distriktssköterskeutbildning eller genomgått för ändamålet anordnad kompletteringskurs ävensom att **sköterskans³** tjänstgöringsförhållanden regleras i enlighet med föreskrifterna i 1935 års kungörelse

angående statsbidrag till distriktsvård. Med hänsyn härtill och då utskottet utgår ifrån, att medicinalstyrelsen vid fastställande av planer för distriktsvården i görligaste mån beaktar av kommunerna framförda önskemål i förevarande hänseende, anser utskottet icke erforderligt, att framställning i ämnet göres till Kungl. Maj:t.

Kungl. Maj:ts förslag har icke givit utskottet anledning till erinran.

Utskottet hemställer alltså,

5. Axel Mannerskantz (Högerpartiet, man)

Herr talman! I den av mig i denna fråga väckta motionen har jag framhållit några synpunkter, som aktualiserats särskilt under själva planläggandet av distriktsvården inom landstingsområde. Det har sålunda visat sig, att förhållandena äro ganska olika i olika slags kommuner. I vissa kommuner har man sedan gammalt haft **sjuksköterskor³** anställda. De ha under kanske många år utövat en synnerligen välsignelsebringande verksamhet och blivit uppskattade av kommunernas befolkning. I andra kommuner har denna fråga kanske inte varit så tillfredsställande ordnad. Där har befolkningen inte vant sig vid att ha tillgång till någon, som kan bedriva hemsjukvård. I ännu en grupp ha två eller flera kommuner slagit sig tillsammans, antingen i kommunalförbund eller endast genom en överenskommelse, för att anställa sådana **sköterskor³**; dessa tjänster kunna vara av olika natur, antingen församlingssystrar eller ock rena **sjuksköterskor³**.

Nu har man visserligen klart för sig, att den fordran inte kan uppställas, att en distriktssköterska skall bestrida all sjukvården inom distriktet. Men man har ändå anledning tro, att i de delar av landet, där bebyggelsen är särskilt gles, och där befolkningen kanske är beskaffad på ett särskilt sätt, en socialhygienisk upplysningsverksamhet inte kommer att ha samma effekt, om speciella befattningshavare tillskapas enbart för detta, som om den handhaves av en **sjuksköterska³**, som människorna äro vana att kalla på, när de äro i något trångmål, vid sjuklighet eller dylikt. Om denna **sköterska³** vid sina besök utnyttjar den vänliga inställning, som folket i stugan redan har mot **henne²**, till att försöka höja deras socialhygieniska vanor, bör **hon²**, åtminstone som jag ser saken och med den kännedom jag har om en massa människor av denna kategori, ha mycket större chans att nå ett resultat, än om det kommer en så att säga enbart socialhygienisk **sköterska³**, som rätt oombedd tränger sig in för att försöka höja befolkningens standard och vanor.

Detta är en synpunkt. En annan synpunkt är den, att de geografiska förhållandena faktiskt äro sådana i stora delar av landet, att en **sköterska³**, som skall vara verksam över ett mycket stort område med i medeltal tre tusen invånare, får använda en alltför stor del av sin tid enbart till förflyttning.

Vidare komma inte de kommuner, som redan ha sin sjukvårdsfråga ordnad genom **sjuksköterskor³**, att avstå från dessa, utan de komma att bibehålla dem. Därigenom kommer denna socialhygieniska **sköterska³** att framstå som en extra person, som givetvis måste ha ett visst

samarbete med de **sjuksköterskor³**, som finnas; och av vissa skäl har jag en föraning om, att detta samarbete inte alltid kommer att gå friktionsfritt.

Nu vet jag ju, att de socialhygiecniska teoretikerna och de, som ha till yrke att syssla med dessa problem, anse det vara förkastligt att sammanblanda den förebyggande och den sjukvårdande verksamheten, och det är ju möjligt; jag tror i varje fall, att detta kan vara riktigt, där förhållandena äro längre framskridna i vissa avseenden. I städer, samhällen och tättbebyggda landsbygdsdistrikt skulle jag sålunda inte hålla för osannolikt, att detta kan vara det riktigaste. Men om man föreställer sig, att det skulle gälla var som helst i landet, tror jag nästan man måste säga, att det visar, att man har för litet erfarenhet om människornas psyke. Jag tror mig utan svårighet kunna ange familjer — och då ofta sådana, där en socialhygienisk upplysning bäst behövs — som faktiskt skulle visa en sådan **sköterska³** på dörren, om **hon²** kommer, när **hon²** inte är kallad och inte kommer när **hon²** är kallad för att hjälpa. Är **hon²** kallad blir ju inställningen en helt annan; då hör man på och tar kanske också intryck av vad som säges.

Nu säger utskottet, att gällande bestämmelser medgiva så små distrikt, som jag i min motion föreslagit, att man skulle få inrätta. Jag tillåter mig

Anslag till avlöningar åt distriktssköterskor m. m. (Forts.) emellertid att vara litet tveksam, huruvida så är fallet. Anledningen till att Jag har begärt ordet är egentligen, att jag velat få den saken litet mera klargjord. Det står i departementschefens motivering år 1935, som uttryckligen godkändes av utskott — det var sammansatta statsoch andra lagutskottet — och riksdag: »Beträffande distriktens storlek må i anledning av vissa yttranden i ämnet till en början erinras, att det enligt förslaget aldrig avsetts att varje distrikt skulle omfatta 3,000 invånare.» Det förstår jag också. Sedan står det: »Medicinalstyrelsen har tvärtom framhållit, att det exempelvis inom industrialiserade trakter kan vara erforderligt med mindre distrikt, medan i trakter av annan typ distrikten lämpligen böra göras större. Vad styrelsen med sitt uttalande i förevarande del närmast velat framhålla är endast, att det i genomsnitt torde bliva erforderligt med en **sköterska³** per 3,000 invånare.» Då säger jag: för att man inte skall överskrida dessa bestämmelser, fordras ju, att de geografiska och psykologiska förhållandena inom ett landstingsområde äro sådana, att det finns lika många distrikt, som lämpligen böra vara större än 3,000 invånare, som sådana, vilka böra vara mindre, och att detta kan ordnas på det sättet, att medeltalet per distrikt blir just 3,000 invånare. Men sådant kan ju inte inträffa annat än av en ren slump. TI själva verket är det så, att om man utgår, som jag gjort här, från att det vore lämpligt att kombinera sjukvård och förebyggande vård, blir det mycket fler distrikt, som böra vara små, så att även sjukvården kan bli tillgodosedd, och då går det inte att få ett medeltal på 3,000.

Nu finns det två sätt att tänka sig att ordna en sådan sak. Det ena sättet är, att man försöker få en plan godkänd av medicinalstyrelsen, där medelbefolkningen per distrikt är mindre än 3,000. Detta medför ju avsevärt ökade kostnader särskilt för staten, och det är jag inte heller

pigg på att vara med om, då man kan se, att det finns andra sätt att ordna saken. Dessutom tror jag, i motsats mot vad här står, att i de glest bebyggda samhällena behöva distrikten vara mindre just för att sjukvården också skall kunna tillgodoses, under det att man kan ha något större distrikt, där man endast har förebyggande vård.

För att påvisa det andra sättet skulle jag vilja ta ett konkret exempel från min hemtrakt. Där finnas fyra kommuner, som ligga i rad, rena jordbrukskommuner, och de ha två och två slagit sig ihop om var sin **sköterska³**. Nu är det föreslaget, att det skall tillsättas en distriktssköterska för dessa fyra kommuner. Då skulle jag vilja fråga: finns det någon möjlighet för medicinalstyrelsen att med nu gällande bestämmelser godkänna en sådan plan, att två **sköterskor³** bleve anställda och att bara halva statsbidraget utginge till vardera? Då skulle staten ju slippa undan med oförändrad kostnad. Koxumunerna komma inte heller att få det dyrare, ty de ha sina **sköterskor³** förut och komma att ha dem kvar. Distrikten få bara 1,500 invånare, och **sköterskorna³** befara dem så pass ofta, att de faktiskt ha tid och möjlighet att utöva en mycket nyttig socialhygienisk verksamhet. Kommunerna befria då också landstinget från att hålla bostad, de hålla vedbrand och äro också villiga att bidraga med kontanta belopp, motsvarande halva statsbidraget, kanske också en del av landstingets bidrag, och ändå ha kommunerna vunnit på saken. Därigenom ha både kommunerna, landstingen och staten fått det ekonomiskt fördelaktigare, än vad de skulle få med ett schablonmässigt tillämpande av de gällande bestämmelserna, så som jag tror de böra tolkas. Men om det nu kan göras ett uttalande, att det redan med nuvarande bestämmelser inte är omöjligt med ett sådant förfaringssätt, utan att medicinalstyrelsen skulle kunna gå med på några sådana eller liknande anordningar, då, herr talman, skall jag avstå från att yrka bifall till mitt förslag, ty då har jag vunnit mitt syfte.

6. Wilhelm Källman (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Jag har först och främst begärt ordet för att uttrycka min tillfredsställelse med att de s. k. landstingsstäderna samtliga komma att inbegripas i distriktsvården. Detta har betydelse inte bara för de uppgifter, som åligga distriktsvården i allmänhet, utan också för de kommande uppgifterna med avseende å förebyggande **mödraoch²** barnavård, den skärpta dispensärvården m. m.

Med avseende å vad herr Mannerskantz anfört, vill jag framhålla, att det kommer att innebära ett oerhört besvärligt detaljarbete, om man skulle godkänna sådana principer för statsbidragets utgående, som han önskat genomförda. Därtill kommer, att den brist på **sköte rskor³**, som vi nu ha att räkna med, gör, att vi knappast ha möjlighet att få sökande till av distriktsvårdsstyrelse ledigannonserade platser. Vid sådant förhållande kan jag knappast fatta, hur det skulle vara möjligt för kommunerna att konkurrera med landstingen och icke-landstingsstäderna, då det är fråga om att skaffa fram **sköterskor³**. Vi ha i vårt län en mycket färsk erfarenhet. Det visar sig vara nästan hopplöst att få tillräckligt med **sköterskor³** . MWNärskilt vill jag framhålla, att när vi nu försöka att tillmötesgå medicinalstyrelsens cirkulär av den 30 maj 1936, så är det inte tänkbart att få sökande till assistentsköterskebefattningar. Även om man nu skulle tänka sig, att icke utbildade, vi kunna

kalla dem hemvårdarinnor eller något dylikt, bleve likställda och att man för dem finge statsbidrag, är detta ett problem, som nog tarvar en närmare omprövning, innan man kan gå med på något i den vägen.

Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

7. Wilhelm Björck (Socialdemokraterna, man)

Herr talman! Jag tror det är nödvändigt, att man till en början klargör, att herr Mannerskantz nog missuppfattat distriktssköterskans uppgifter, när han här talade om enbart socialhygieniska **sköterskor³**. Mig veterligt är det inte möjligt att ordna distriktsvården på sådant sätt, att man har enbart socialhygieniska **sköterskor³**. Det finns en möjlighet, att distriktsvårdsstyrelsen har en **sköterska³** i varje distrikt, som är så att säga dess särskilda assistentsköterska, men i övrigt är ju grundvalen för distriktssköterskereformen, att det skall bedrivas såväl socialhygienisk som individuell sjukvård. Det är en av hörnpelarna i reformen, och därifrån bör man alltså utgå vid sina överväganden.

När sedan herr Mannerskantz beklagar sig över att det är för litet med en **sköterska³** på 3,000 invånare, så är det mycket möjligt, men jag vill säga, att i det enda fall, där jag känner, att meningsskiljaktighet förelegat mellan medicinalstyrelsen och landstinget, gällde det, att det ansågs för mycket med en **sköterska³** på 3,000 invånare. Det var Gotlands län, som hade fått ett föreläggande, som Kungl. Maj:t undanröjde, just därför att man från landstingets sida inte ville ha mer än 11 **sköterskor³** — eller vad det nu var — på hela Gotland.

Vad sedan beträffar den kommunala **sköterska³**, som herr Mannerskantz ömmar för i sin motion, så har det ju vid utskottsbehandlingen utretts, att det mycket väl går för sig att inlemma **henne²** i distriktsvårdsorganisationen på det viset, att kommunen fortfarande betalar sin **sköterska³** och får in **henne²** i distriktsvårdsorganisationen, om **hon²** verkligen är kompetent eller kan göras kompetent. Däremot tror jag inte, att det skulle vara tänkbart, att man delade statsbidraget på olika **sköterskor³**, utan det får bli en gemensam distriktssköterska i angränsande kommuner, men genom att man kopplar in den där kommunalt avlönade **sköterskan³** såsom distriktssköterska, får man ju ett större antal **sköterskor³** i hela landstingets organisation, utan att därmed statsbidraget behöver växa.

Jag tror alltså, att den utredning, som här föreligger, är tillfredsställande

Herr talman! Jag ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

8. Axel Mannerskantz (Högerpartiet, man)

Herr talman! Herr Källman nämnde, att bristen på **sköterskor³** skulle vara ett avgörande motiv för avslag på mitt förslag. Då vill jag tvärtom framhålla, att i det exempel, som jag drog, var det just meningen att spara in en **sköterska³**, så att man slapp den tredje **sköterskan³**, som for omkring, där det förut fanns två kommunala **sköterskor³**. Denna tredje **sköterska³** är onödig, anser jag, när distrikten inte äro större än vad det här är fråga om.

När herr Björck säger, att det är meningen, att båda vårdformerna skola finnas, så vet jag mycket väl, att det är avsett att bli så, men det finns ju ingen människa, som tror, att det gärna kan bli mer än den ena vårdformen, när distrikten skola ha den storlek, som är föreslagen, och man håller ju ganska hårt på det; jag vet, att chefen för medicinalstyrelsen håller särskilt hårt därpå, och det är därför jag är ganska säker på att tanken har varit, att sjukvårdsbehovet skall fyllas på annat sätt. Det få kommunerna klara själva. Jag tror inte, att det är möjligt att säga, att man har kopplat in en kommunal **sköterska**[3] 1 distriktsvården, med mindre än att **hon**[2] får bidrag från något annat håll än kommunen. TI annat fall är det ju inte något inkopplande. Då skulle man ålägga **henne**[2] de socialhygieniska uppgifterna enbart mot ersättning från kommunen och det kan väl knappast sägas vara ett inkopplande i systemet.

Herr talman! Jag förstår, att det finns vissa möjligheter att ordna så, att det nuvarande systemet inte blir så olägligt, men de väsentliga olägenheterna kvarstå i alla fall, och jag anser, att man litet närmare borde tänka över detta.

Med hänsyn till att här inte givits någon mera klarläggande tolkning, herr talman, finner jag mig föranlåten att yrka bifall till motionen.

9. Martin Svensson (–, man)

Herr talman! Motionären har ju fått sin motion ganska välvilligt behandlad av utskottet, och jag för min del tror, att medicinalstyrelsen kan fastställa en plan, vari utstakas ett område, vari medges, att inom detta må vara anställda två **sköterskor**[3], men det blir inte statsbidrag till mer än en. Däremot går det sannolikt inte att dela ett sådant distrikt i två smådistrikt, som vart för sig skulle få ett halvt statsbidrag. Detta är min personliga mening om den fråga, som motionären framställde här.

I lagen om distriktsvårdens ordnande har man utgått från en normal storlek på distrikten av 3,000 invånare, men det förhåller sig ju så, som statssekreterare Björck nyss nämnde, att det är svårt att ens inrätta så många distrikt, att man får en **sköterska**[3] per 3,000 invånare på landsbygden. I den mån man kan öka distriktens antal, kommer det nog sådana fall, då distrikt delas, som visa sig ha behov av ett ökat antal **sköterskor**[3].

När jag hör motionärens framställning här och läser motionen, kommer jag till den uppfattningen, att han ser distriktssköterskornas uppifter så, att enligt förordningen kommer den socialhygieniska vården att få företrädesrätt. Han däremot vill, att hemsjukvården skall ha företräde, och han tänker sig, att denna senare vård skulle bli bättre tillgodosedd genom hans förslag. Jag tror emellertid, att där kommuner eller organisationer skaffat sig sjuksystrar eller församlingssystrar för denna hemsjukvård, dessa böra betänka sig mer än en gång, innan de uppge den frihet, de nu ha. Ekonomiskt skulle de ju inte vinna synnerligben på att vården inordnas under distriktsvården. Efter mitt sätt att se tala åtskilliga skäl för att dessa kommuner eller stiftelser eller orga-

Jag yrkar bifall till statsutskottets hemställan.

Vidare har i en inom andra kammaren av herr Å. Holmbäck väckt motion (nr 370) hemställts, att det i propositionen nr 134 föreslagna belopp av 100,000 kronor, med vilket det i riksstaten för 1937/38 uppförda förslagsanslaget till oförutsedda utgifter skulle få tagas i anspråk till förmån för hemlösa barn i Spanien, måtte höjas till 200,000 kronor.

10. Georg Branting (Socialdemokraterna, man)

Herr talman, mina herrar! Det kan ju inte vara annat än naturligt att uttrycka tillfredsställelse över regeringens initiativ i denna fråga. Att Sveriges regering och riksdag ägnar en tanke och en välvillig gest åt de hemlösa barnen i Spanien och nu särskilt ömmar för deras förseende med livsmedel, därom är självklart ingenting annat än gott att säga. Det tycks mig, som om man också vid denna humanitära hjälpverksamhets planerande äntligen har befriat sig från den osympatiska tvångsföreställning, som hittills länge nog tycks ha behärskat tankegångarna på mer eller mindre officiellt håll, nämligen att det inte skulle gå för sig att ge åt den ena sidan, utan att man samtidigt skall ge precis lika mycket åt den andra sidan och att på det sättet indela hungrande och nödlidande barn i röda barn och vita barn. Denna sorts neutralitet förekommer lyckligtvis inte i det papper, som vi nu ha framför oss; man går efter behovsprincipen, och det måste också vara det riktiga.

Vad beloppet beträffar, kan man ju säga, att något är bättre än intet. Det är cirka fem procent av vad som på frivillighetens väg har insamlats i Sverige. Utskottet har för övrigt, synes det mig, givit ett ganska torftigt referat av vad som härutinnan har förekommit, och det skulle väl vara frestande att i detta sammanhang ge kammaren ett referat över vad exempelvis Svenska Hjälpkommittén för Spanien har bedrivit för verksamhet till hjälp åt de spanska barnen. Men det får anstå till något annat tillfälle. Jag förstår i och för sig att man anlägger vissa restriktiva synpunkter, när statsmakterna disponera skattemedel för humanitär hjälp i utlandet.

Men det är en annan synpunkt, herr talman, som också tränger sig på i detta sammanhang. Just de händelser, om vilka denna morgon bringat budskap, göra, att man blir benägen att som ett uttryck för vad man känner yrka bifall till den motion, som i detta ärende är väckt av herr Holmbäck. Svenska regeringen och svenska riksdagen ha kanske observerat, att barnen i Spanien icke bara svälta och frysa, utan att de också i väldiga mängder dödas, att de sprängas i småbitar vid luftbombardemang av öppna städer och byar, att barnen nedmejas av flygmaskinernas kulsprutor, att massor av barn lemlästas och andra mängder av barn få sina nerver spolierade för all framtid eller sitt förstånd förmörkat genom de fasor, som luftkriget nu låter övergå den spanska civilbefolkningen. Man vet ju också, att allt detta sker — icke av olyckshändelse, i sammanhang med de egentliga krigsoperationerna, utan med full vilja, 1 avsikt att injaga skräck och fasa och underkastelse.

Svenska regeringen och riksdagen tycka kanske, att detta är saker, som inte höra hit. Enligt

mitt förmenande hör emellertid detta spörsmål hit, ty nu behandla vi frågan om humanitär hjälp åt spanska barn, som, mina herrar, befinna sig i den största tänkbara nöd! Jag gör för min del den fega non-

Jag vill tillåta mig att till dagens protokoll anföra några av de uppgifter. som nu inlöpande telegram meddela angående bombardemangen av Barcelone. Till klockan 12 i går hade man dragit fram 1,300 lik bland Barcelonas ruiner. 2,000 människor hade förts till sjukhus. Ett flertal sjukhus och andra liknande anläggningar ha förstörts. Dessa bombardemang fortsätta alltjämt, troligen i denna stund! Från den fascistiska sidan har man i ultimativ form meddelat, att bombardemangen skola fortsätta var tredje timme, till dess att man på det sättet tvingat den republikanska sidan på knä.

Specialtelegram ge beskrivningar av vad som förekommit. Ett telegram lyder på följande sätt: »Under rebellflygets intensiva bombardemang av Barcelona förföljdes barcelonabor, som flytt till skogarna i stadens omgivningar. av rebellmaskiner som besköto dem med sina maskingevär. En vagn, som transporterade **kvinnor**[1] och barn i närheten av Barcelona, träffades av en bomb. Alla som sutto i vagnen dödades.»

Den engelska tidningen Daily Express" korrespondent i Barcelona, Sefton Delmer, skildrar i en artikel, som just nu publiceras, de fruktansvärda bombardemang, som Barcelona utsatts för under det senaste dygnet. Han skriver: »Sedan tjugutvå veckors tid sprida oavbrutet tyska och italienska flygare i Francos tjänst död och förintelse över Barcelona. Jag tvekar inte att säga, att dessa bombardemang äro de värsta, som en storstad någonsin utsatts för. Med egna ögon har jag sett lastbilar med hela berg av lik, som i all hast fördes tili bårhuset. Jag har sett grupper av förtvivlade människor gräva 1 spillrorna av hus på fem och sex våningar för att hämta fram lik. Jag har sett sårade hämtas av privata ambulanser och föras till sjukhusen, medan bärarna med sotiga ansikten och dammiga stålhjälmar oupphörligt ilat fram och tillbaka med bårar, från vilka blodet strömmade, för att samla upp nya offer. Dessa bombräders enda syfte är att sprida skräck bland civilbefolkningen, åstadkomma panik och på så sätt försöka tvinga regeringen att kapitulera. De flesta bomberna äro högexplosiva och ha den egenskapen att de, så snart de träffa marken, krevera med fruktansvärd kraft. De äro icke konstruerade för att åstadkomma större materiella skador, utan för att döda människor. Detta slags bomber användes vid fronterna. Jag har hört dem komma vinande och sett dem explodera. Jag har sett enorma rökmoln stiga upp från de platser, där de flesta bomberna slagit ned. Min bil var upprepade gånger nära att kollidera med ambulanser, som kommo susande i vanvettig fart i riktning mot de hemsökta kvarteren, och med lastbilar, som voro på väg tillbaka därifrån. Jag såg ett hål, icke så särdeles djupt men omkring tre och en halv meter brett, mitt på den mest trafikerade platsen i Barcelona. På andra sidan brann en kullstjälpt automobil. Tre spårvagnar lågo likaledes kullvälta på platsen. Kaféernas fönster voro splittrade. Två arbetare buro i en korg bort de förbrända kvarlevorna av en man. I rännstenen rann en ström av blod från män och **kvinnor**[1], som lemlästade lågo på trottoarerna, dödade av de exploderande bomberna. Ambulanser och röda-korsmän forslade bort offren. Andra

män samlade ihop kringströdda fragment av söndersprängda kroppar. En av de mest gripande bilderna i detta hemska skådespel utgöra bönderna, som genom Francooffensiven bortjagats från sina hem och föregående natt anlänt till Barcelona. Utmattade och uthungrade hade de släpat kärror med sina fattiga ägodelar bort från frontzonen endast för att finna, att de på nytt råkat in i kri-

Mina herrar! Häromdagen tillät jag mig i denna kammare fråga, vad som kunde föranleda Sverige att deltaga i den internationella politik, som nu föres emot Spanien. Herr statsrådet Westman upplyste mig då, att vi härvidlag handla utan påtryckning och av fri vilja. Vi vägra att leverera försvarsvapen för Spaniens **kvinnor**[1] och barn med den motiveringen, att denna politik är fredsbefrämjande! Menige man förstå inte detta språk, mina herrar!

Herr talman! Jag vill tillåta mig att rikta en allvarlig vädjan till den svenska regeringen att omedelbart göra allt vad på den kan ankomma för att sätta en gräns för de omänskligheter, som just nu övergå den spanska civilbefolkningen och som äro för hela vår civilisation djupt kränkande. Jag tror inte, att man i vårt land vill i någon form bära ett moraliskt medansvar för dessa massakrer.

Vad yrkande beträffar vill jag tillåta mig att med hänvisning till vad jag nu refererat och som ett uttryck för vår inställning härtill yrka bifall till motionen om det högre anslaget på 200,000 kronor.